

MEMENTO – SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA

Saúde Mental é o estado de bem-estar no qual uma **pessoa é capaz de lidar com os estresses normais da vida, ser produtiva no trabalho e contribuir para a sua comunidade** (OMS).

→ **não é apenas a ausência de doenças mentais**, mas envolve um equilíbrio emocional, psicológico e social.

A qualidade de vida é a percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, no contexto da cultura e do sistema de valores em que está inserido, em relação aos seus objetivos, expectativas e preocupações.

É um conceito que pode se apresentar como sinônimo ou complementar a outras concepções como saúde e bem-estar.

A QUALIDADE DE VIDA é um conceito DINÂMICO, pois depende das motivações, necessidades e expectativa de cada um

→ **é contingencial**, na medida em que se modifica conforme as circunstâncias;
→ abrangente e multidisciplinar, **engloba todas as esferas da vida humana**;
→ **é alvo de interesse de várias ciências**, como saúde, psicologia, economia, administração, sociologia etc.

SAÚDE

→ estado de completo bem-estar físico, social e mental.

BEM ESTAR

→ parte de uma perspectiva subjetiva, que considera a prevalência de estados afetivos positivos sobre os negativos, e também de uma perspectiva psicológica, que compreende o bem-estar como resultante de experiências de realização pessoal e possibilidade de desenvolvimento dos potenciais individuais.

A saúde mental e a qualidade de vida estão intrinsecamente ligadas;

→ quem tem boa saúde mental tende a ter uma percepção mais positiva de sua qualidade de vida.

→ por outro lado, **problemas na saúde mental podem resultar diminuição da qualidade de vida.**

Ambiente de trabalho – impacto significativo na saúde mental:

→ **estresse, pressão por resultados, falta de apoio social e condições físicas do trabalho** são

fatores que podem afetar a saúde mental dos colaboradores.

→ **afeta, inclusive, a produtividade da organização.**

APLICAÇÕES PRÁTICAS NO AMBIENTE DE TRABALHO

I – Promoção de programas de saúde mental;

→ conscientização + oferta de suporte psicológico;

Ex.: workshops e treinamentos (capacitação para líderes e colaboradores);

Ex2.: políticas de apoio psicológico → disponibilização de serviços de psicologia e psiquiatria.

II – Estabelecimento de um ambiente de trabalho positivo;

→ flexibilidade (horários flexíveis e modelos de trabalho híbrido permitem um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional).

→ apoio social entre colegas de trabalho (senso de equipe e colaboração);

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT)

QVT → Louis Davis, 1970;

Davis definiu QVT como a **preocupação com o bem-estar geral e saúde dos colaboradores** no desempenho de suas atividades.

Atualmente o conceito envolve aspectos físicos, ambientais e psicológicos do local de trabalho.

Assimila duas posições antagônicas: a dos colaboradores e o interesse das organizações quanto aos seus efeitos sobre a produtividade.

QVT é um conjunto de ações de uma empresa envolvendo diagnóstico e implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro e fora do ambiente de trabalho, visando a propiciar condições plenas de desenvolvimento humano para e durante a realização do trabalho.

É resultante direta da combinação de diversas dimensões básicas do desempenho das atividades e de outras dimensões não dependentes diretamente das tarefas, capazes de produzir motivação e satisfação em diferentes níveis.

MEMENTO – SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA

Independentemente das percepções que os funcionários possam ter, A QVT deve envolver:

- a) Satisfação com o trabalho executado (trabalho que valha a pena ser feito);
- b) condições de trabalho seguras;
- c) remuneração justa + benefícios auferidos;
- d) segurança no emprego;
- e) supervisão competente;
- f) possibilidades de promoção e avanço na carreira;
- g) oportunidades de crescimento intelectual e profissional;
- h) excelente clima social e justiça;
- i) retroação quanto ao desempenho no trabalho.
- j) liberdade de atuar e a responsabilidade de tomar decisões.

No fundo, a QVT busca uma visão integral e ética do ser humano em seu relacionamento com as organizações.

A competitividade organizacional – e, obviamente, **a qualidade e a produtividade** – passam obrigatoriamente pela QVT.

→ para atender ao cliente externo, a organização não deve esquecer o cliente interno.

“coloque os empregados em primeiro lugar e eles colocarão os consumidores em primeiro lugar”.

→ a organização que investe diretamente no colaborador está investindo indiretamente no cliente.

ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE MENTAL

1. Comunicação clara e abertura

→ deve-se cultivar um ambiente onde os colaboradores se sintam à vontade para expressar suas preocupações e buscar ajuda quando necessário.

2. Reconhecimento e valorização dos colaboradores

→ ao investir no bem-estar de seus colaboradores, a organização não apenas contribui para a saúde individual, mas também para a produtividade e eficiência do ambiente de trabalho.

FATORES QUE IMPACTAM A SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA

A atividade policial, por suas características e peculiaridades, expõe o PM a situações de elevado risco e estresse físico e emocional.

Ex.: **risco de morte, contato regular com a violência e criminalidade, colegas alvejados ou mortos em serviço, cobrança por desempenho livre de erros e falta de reconhecimento social.**

→ **Fatores que POTENCIALIZAM o risco de adoecimento mental de TODOS OS POSTOS e graduações;**

A formação do policial militar é perpassada por um ideal de homem que se estrutura em princípios rígidos;
→ a padronização de condutas, atos e fardamentos tende a dificultar a expressão do que é subjetivo, individual e singular;

Teoria Psicodinâmica do Trabalho (DEJOURS, 1998)

→ **o trabalho**, assalariado ou beneficente, doméstico ou profissional, público ou privado, **mobiliza o corpo, a inteligência e a própria pessoa para uma produção de valor.**

Essa ideia propicia uma melhor compreensão do trabalho e do **trabalhador policial militar**, que geralmente é **visto pela sociedade como o “braco armado do Estado”, como repressores, violentos e não como seres humanos.**

A temática da saúde mental dos PMs está intimamente ligada à temática da vitimização policial: riscos da profissão e vulnerabilidades físicas e psíquicas desses profissionais.

→ Em 2022, 18 PMs foram mortos em confronto em serviço, sendo 02 em PE.

Obs.: Os dados sobre suicídio de PMs da ativa são permeados de incerteza.

→ **A existência de estigmas em torno da saúde mental e da busca de ajuda é uma característica que a PMPE compartilha com outras forças de segurança no Brasil e no mundo.**

COMPREENDENDO OS IMPACTOS À SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA DO PM: A ÁRVORE DO PROBLEMA

Raízes → causas (alimentam o problema):

Ex.: estigmas de saúde mental, estresse ocupacional, rejeição social do trabalho, cultura de invulnerabilidade, uso de álcool e substâncias, acesso à arma de fogo, demandas da vida privada, adoecimento físico e mental;

MEMENTO – SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA

Tronco → o problema principal;

Ex.: vitimização policial por problemas de saúde mental (transtornos mentais e sofrimento psíquico).

Copa (folhas e frutos) → efeitos (como o problema aparece).

Ex.: elevado número de reformas por transtornos mentais, suicídios e homicídios seguidos de suicídios, elevados números de LTS e RTS, absenteísmo/presenteísmo.

TRANSTORNOS MENTAIS MAIS COMUNS ENTRE OS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

O trabalho na área de segurança pública é um dos mais arriscados no que tange aos riscos à saúde ocupacional, sendo esses profissionais expostos a condições que os colocam frente a riscos diários, numa condição limítrofe para o desenvolvimento de transtornos mentais.

→ a necessidade de estar sempre alerta e de prontidão em qualquer situação, inclusive na folga, um regime disciplinar rígido e outras especificidades da profissão, como privação de sono, trabalhos por turno, risco de morte, contato direto e constante com a violência, torna os policiais vulneráveis aos transtornos mentais.

Os principais transtornos entre esses profissionais são:

1. Ansiedade;
2. Depressão;
3. Estresse (agudo e pós-traumático).

A PMPE dispõe de um Núcleo de Saúde Mental que presta atendimento psicológico presencial e on-line aos PMs pernambucanos.

→ De acordo com o Núcleo, os principais transtornos mentais entre os PMPE são ansiedade, depressão e transtorno bipolar.

ESTRESSE

Processo pelo qual alguém percebe e responde a eventos julgados desafiadores ou ameaçadores.

→ **reação psicofisiológica complexa** que tem em sua gênese a **necessidade de o organismo fazer face a algo que ameaça a sua homeostase (equilíbrio) interna.**

→ está em nosso cotidiano e pode vir de várias direções → família, estresse ambiental, estresse relacionado ao trabalho e fatores socioculturais.

Na maioria dos casos, é uma experiência rápida. O estresse persistente ou crônico

pode influenciar na vulnerabilidade da pessoa a doenças.

→ sobrecarrega os recursos de enfrentamento;

Doenças relacionadas ao estresse:

→ doenças cardíacas e hipertensão.

O estresse ocorre em 4 fases (curva do estresse):

a) Alerta

→ diante de um desafio ou ameaça percebida, a pessoa necessita produzir mais força e energia a fim enfrentar a situação desafiadora.

→ as mudanças fisiológicas neste momento **contribuem para que haja aumento da motivação, entusiasmo e energia, o que pode, desde que sem excesso, gerar maior produtividade.**

→ é a fase positiva do estresse, onde há uma energização pela produção de adrenalina e a sobrevivência é preservada com sensação de plenitude.

b) Resistência

→ o **estresse persiste** e há uma **grande utilização de energia em busca do reequilíbrio**, causando a sensação de desgaste generalizado.

→ o **desgaste e a falta de memória são sinais** de que a demanda ultrapassou a capacidade da pessoa lidar com a situação.

→ **tentativa de manter a homeostase interna**

→ se os fatores estressores persistirem há uma quebra da resistência e a pessoa entra na fase de quase exaustão.

c) Quase Exaustão

→ as defesas do organismo começam a ceder e ele já não consegue resistir às tensões e reestabelecer o equilíbrio.

→ oscila entre momentos de tranquilidade e momentos de desconforto, cansaço e ansia;

→ **as doenças começam a aparecer.**

→ **órgãos com maior vulnerabilidade** genética ou adquirida **passam a mostrar sinais de deterioração.**

d) Exaustão

→ recursos esgotados → quebra total da resistência.

→ sintomas semelhantes ao do alarme, embora em maior magnitude;

→ pode ocorrer a exaustão psicológica em forma de depressão e a exaustão física na forma de doenças (úlceras, infarto, psoríase etc).

→ embora seja grave, **não é irreversível.**

MEMENTO – SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA

Obs.: a depressão passa a fazer parte dos sintomas do estresse na fase de quase exaustão e se prolonga até a fase de exaustão.

Em síntese, como consequência da queda do sistema imunológico, doenças que permaneciam latentes podem ser desencadeadas como úlceras, hipertensão, diabetes, problemas dermatológicos, impotência e obesidade.

BORNOUT (síndrome do esgotamento profissional)

→ é um **distúrbio emocional com sintomas de exaustão externa, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante**, que demandam muita competitividade ou responsabilidade.

→ comum em profissionais que atuam sob pressão e responsabilidades constantes, como PMs, Médicos, Professores e Jornalistas, Operadores de Telemarketing.

ATENÇÃO

→ **Estresse e Bornout não são sinônimos**, na medida em que o **Bornout é a resposta a um estado prolongado de estresse** que ocorre pela cronificação deste em tentar se adaptar a uma situação claramente desconfortável no trabalho.

Principal causa: excesso de trabalho.

→ **pode resultar em estado de depressão profunda** e por isso é **essencial procurar apoio profissional no surgimento dos primeiros sintomas**.

O estresse e a falta de vontade de sair da cama ou de casa, **quando constantes**, podem indicar o início da doença.

Seus sintomas surgem de forma leve e tendem a piorar com o passar dos dias, por isso, muitas pessoas acham que pode ser algo passageiro.

Seus principais sinais/sintomas:

- cansaço excessivo, físico e mental;
- alterações no apetite;
- insônia;
- dificuldades de concentração;
- sentimentos de fracasso e insegurança;
- negatividade constante;
- **sentimentos de incompetência, derrota e desesperança**;
- alterações repentinas de humor;
- fadiga, isolamento e dores musculares;

→ problemas gastrointestinais, alteração nos batimentos e pressão alta.

Tratamento e Prevenção

- atividade física regular;
- exercícios de relaxamento;
- psicoterapia e medicação;
- possíveis mudanças no ambiente de trabalho, inclusive, se for o caso, mudança de ocupação ou atividade.

DEPRESSÃO

→ **tristeza constante e prolongada** – envolve uma ampla família de doenças;

→ é a doença mental de mais elevada prevalência e é a mais associada ao suicídio.

→ **problema médico grave e altamente prevalente na população em geral**. (15% dos brasileiros já tiveram ao longo da vida).

→ A época comum do aparecimento é o final da 3ª década de vida, mas pode começar em qualquer idade.

Tristeza profunda na maior parte do dia, por um período mínimo de 02 semanas, + **sentimentos de dor, culpa, amargura**, perda do interesse, **ausência de ânimo, baixa autoestima** e oscilação de humor.

→ **pode gerar paralisação, incapacidade e levar a pensamentos suicidas** → **a vida parece não ter mais sentido**.

Causas da depressão:

a) Genética

→ 40% da suscetibilidade para desenvolver depressão;

b) Bioquímica cerebral

→ deficiência de neurotransmissores como Noradrenalina, Serotonina e Dopamina – envolvidos na regulação da atividade motora, apetite, sono e humor.

c) Eventos vitais

→ estresses, traumas e perdas, especialmente quando combinados com o componente genético.

Sintomas da depressão:

a) humor depressivo

b) retardo motor

MEMENTO – SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA

→ falta de energia, preguiça ou cansaço excessivo + falta de memória e vontade.

c) insônia ou sonolência

→ mais associada à depressão atípica.

d) apetite

→ geralmente é diminuído, podendo ocorrer algumas formas de aumento, como o maior interesse por carboidratos e doces.

e) redução do interesse sexual

f) dores e sintomas físicos difusos.

→ mal-estar, dor no peito, queixas digestivas.

Fatores de risco:

→ histórico familiar;

→ estresse e ansiedade crônicos;

→ transtornos psiquiátricos correlatos;

→ disfunções hormonais;

→ traumas psicológicos;

→ dependência de álcool e drogas;

→ conflitos conjugais;

→ mudança brusca de condições financeiras e desemprego.

ATENÇÃO

→ O **diagnóstico da depressão é clínico, feito pelo médico** após a coleta completa da história do paciente e realização de um exame do estado mental.

A depressão pode se apresentar de formas específicas, conforme os seguintes subtipos:

a) Distímia

→ quadro **mais leve e crônico**;

→ **alterações na maior parte do dia, todos os dias, por pelo menos 02 anos.**

→ excesso de preocupação;

→ as alterações de apetite, libido e psicomotoras não são frequentes, sintomas como letargia e falta de prazer pelo que outrora era prazeroso são mais comuns.

→ a maioria dos casos ocorre na adolescência ou no início da fase adulta.

b) Depressão endógena

→ predominam sintomas como perda de interesse em atividades outrora agradáveis, piora pela manhã, lentidão psicomotora, muito desânimo e tristeza, perda de apetite e peso.

c) Depressão atípica

→ aumento de apetite e/ou peso, dificuldade para conciliar o sono, sensação de corpo pesado, sensibilidade exagerada à rejeição.

d) Depressão sazonal

→ início no outono/inverno, remissão na primavera, sendo incomum no verão.

→ prevalece entre jovens que vivem em maiores latitudes;

→ apatia, isolamento social, diminuição da libido, sonolência, aumento do apetite e ganho de peso.

→ para diagnóstico, esses episódios devem se repetir por 02 anos consecutivos, sem episódios não sazonais no período.

e) Depressão psicótica

→ quadro grave com delírios e alucinações.

f) Depressão secundária

→ associada ou causada por doenças médico-sistêmicas e/ou medicamentos.

g) Depressão bipolar

→ a maioria dos pacientes bipolares inicia a doença com um episódio depressivo;

→ história familiar de bipolaridade, abuso de substâncias e transtorno de ansiedade são indícios de evolução bipolar.

Prevenção da depressão:

→ busca de um estilo de vida saudável;

→ dieta equilibrada + atividade física + rotina de sono regular + **não interromper tratamento sem orientação médica** + evitar o álcool + diminuir a cafeína + não usar drogas ilícitas.

O tratamento é medicamentoso e psicoterápico.

É de fundamental importância a adesão ao tratamento, uma vez interrompido por conta própria pode aumentar significativamente o risco de cronificação.

TRANSTORNO BIPOLAR

Caracteriza-se por alterações de humor que provocam alterações de comportamento, levando a pessoa a oscilar entre euforia e depressão repentinamente.

→ tende a começar na adolescência ou no início da fase adulta;

→ a hipomania (mania de intensidade leve) pode ser um sinal precoce da doença.

Não há uma causa definida, mas acredita-se que diversos fatores possam estar envolvidos nas

MEMENTO – SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA

oscilações de humor provocadas pela doença, como:

- fisiologia do cérebro;
- desequilíbrio entre os neurotransmissores;
- desequilíbrio hormonal;
- fatores genéticos;
- estresse;
- violência sexual e experiências traumáticas;
- uso de drogas (ex.: cocaína e anfetaminas).

Divide-se em três fases e três tipos:

Fases

1. Mania

- exaltação do humor sem qualquer relação com o momento;
- humor eufórico, irritável ou mesmo jocoso ou arrogante + mania de grandeza.

2. Hipomania

- estado de mania mais leve;
- funcionamento acelerado, mas produtivo para o paciente.
- muitos pacientes quando estão entrando em hipomania resistem a manter o tratamento.

3. Depressão

- mesmos sintomas de um episódio depressivo.
- humor deprimido, falta de energia, de iniciativa e vontade, falta de prazer, alteração do sono e do apetite, lentidão do pensamento e motora.

Tipos

1. Tipo 1

- ciclos de oscilação de humor mais definidos e, pelo menos, um episódio maníaco.
- euforia, irritabilidade e comportamentos que destoam do habitual.
- pode durar uma semana, alternando com períodos de depressão profunda.

2. Tipo 2

- ciclos de oscilação mais sutis, não atinge a mania completa e manifesta com mais frequência episódios de depressão.

3. Ciclotimia

- oscilações de humor menos graves.
- assim como o tipo 02, muitas vezes são diagnosticados incorretamente como tendo apenas depressão.

Os sintomas do transtorno bipolar dependem do tipo exato da doença e costumam variar de

pessoa para pessoa, mas faz-se mister destacar os seguintes:

- oscilação de humor;
- irritabilidade;
- alterações de sono;
- pensamentos suicidas;
- episódios de mania, como picos de euforia, pouca necessidade de sono, desvio de atenção e comportamento agressivo;
- episódios de hipomania, paciente mais eufórico, falante e ativo que o habitual.

TRANSTORNOS DE ANSIEDADE

Os transtornos de ansiedade ocorrem quando esta se torna tão intensa e frequente que dificulta o dia a dia.

A ansiedade é uma sensação de nervosismo, preocupação ou desconforto, sendo uma experiência humana normal.

→ está presente em uma gama de problemas de saúde mental.

A ansiedade não patológica tem sua raiz no medo e desempenha um importante papel na sobrevivência, quando uma pessoa se vê diante de um perigo ou ameaça, a ansiedade desencadeia uma resposta de luta ou fuga.

→ é evidente a sua importância para ajudar a pessoa a se adaptar a fatores estressantes mais comuns, motivando-a a se preparar, praticar e ensaiar.

A ansiedade é considerada um transtorno quando:

- **ocorre em momentos indevidos;**
- ocorre com **frequência;**
- é tão **intensa e duradoura que interfere nas atividades normais** da pessoa.

A ansiedade significativa pode persistir vários anos e a pessoa com ansiedade começa a acreditar que isso é normal.

→ assim, muitas vezes os transtornos de ansiedade não são diagnosticados ou tratados. Podem, inclusive, estar associados a pensamentos suicidas e tentativas de suicídio.

Transtorno do estresse agudo, transtorno de adaptação e TEPT → costumam aparecer com a ansiedade proeminente.

Os transtornos de ansiedade tendem a ocorrer concomitantemente a outros problemas médicos e de saúde mental, como depressão, transtorno

MEMENTO – SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA

bipolar, transtornos de personalidade, doença arterial coronariana, asma, enxaquecas e artrite.

As causas dos transtornos de ansiedade não são completamente conhecidas, mas pode haver o envolvimento dos seguintes fatores:

1. ambiente;
2. fatores genéticos (incluindo histórico familiar);
3. doença física (ex.: insuficiência cardíaca);
4. medicamentos, entorpecentes ou outras substâncias.

→ Pode ainda ser iniciado por estresses causados pelo meio, como o fim de um relacionamento importante ou a exposição a um desastre com risco à vida.

A ansiedade tende a ser hereditária. Os médicos acreditam que algumas dessas tendências podem ser hereditárias, mas algumas são provavelmente adquiridas ao longo da vida.

TRANSTORNOS RELACIONADOS A FATORES TRAUMÁTICOS E ESTRESSANTES

TEPT, TEA e T.A → causam sintomas semelhantes, mas diferem na sua duração.

Obs.: embora a depressão e a ansiedade sejam com frequência evidentes em pessoas com transtornos relacionados a fatores traumáticos e estressantes, eles costumam ter uma ampla variedade de sintomas que podem não parecer estar relacionados ao evento traumático.

Transtorno do Estresse Agudo (TEA)

→ reação disfuncional intensa e desagradável que tem início logo após um evento extremamente traumático e **dura menos de um mês**.

→ essas reações de estresse incluem aumento da ansiedade, reviver mentalmente o evento traumático, evitar coisas que relembrem o trauma, mostrar humor negativo, aumento da excitação e desenvolver sintomas dissociativos (inclusive desrealização e amnésia).
→ se os sintomas persistirem, a pessoa será diagnosticada com TEPT.

Obs.: o grau de angústia após um evento traumático em pessoas com TEA tende a ser maior do que o observado em pessoas com T.A.

Obs2.: o número de pessoas com TEA é desconhecido.

→ a chance de uma pessoa apresentar TEA é maior quando os eventos traumáticos são graves ou recorrentes.

Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT)

→ reações intensas, desagradáveis e disfuncionais que ocorrem após um evento extremamente traumático e **duram mais de um mês**.

→ pode se desenvolver como continuação do TEA ou separadamente até 06 meses após o evento.

Eventos de risco à vida ou ferimentos graves podem causar angústia intensa e de longa duração.

→ é possível que a pessoa afetada pelo TEPT reviva o evento, tenha pesadelos frequentes e evite qualquer coisa que possa lembrá-la do evento.

Os eventos mais propensos a causar TEPT são aqueles que invocam sentimentos de medo, desamparo ou horror.

→ combate, agressão sexual e desastres naturais ou provocados pelo homem são causas comuns do TEPT.

→ **esses eventos podem ser vivenciados diretamente** (sofrer lesão grave ou ameaça de morte) **ou indiretamente** (testemunhar as tragédias).

Não se sabe por que um mesmo evento traumático pode causar TEPT vitalício em algumas pessoas, mas não causar nenhum sintoma em outras.

→ é possível que o TEPT crônico não desapareça completamente, mas geralmente fica menos intenso com o passar do tempo, mesmo sem tratamento.

Transtornos de adaptação (T.A)

→ Compreendem **reações a eventos estressantes que podem ser marcos comuns do desenvolvimento** (ex.: tornar-se pai) **ou ocorrências mais perturbadoras de duração variável** (ex.: perder o emprego, cuidar de um familiar doente, ter problemas no relacionamento amoroso) **que causam angústia desproporcional ao evento estressante e levam a dificuldades com o cotidiano.**

Esses transtornos **tendem a se desenvolver logo após o evento e persistem por menos de 06 meses.**

MEMENTO – SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA

→ **podem persistir indefinidamente se o estresse for persistente** (ex.: desemprego crônico).

Manifestações mais comuns do T.A: humor deprimido, ansiedade e má conduta.

→ algumas pessoas podem apresentar apenas um sintoma especialmente proeminente.

→ maior risco de haver tentativas de suicídio e suicídio consumado.

ESTIGMAS E BUSCA DE AJUDA EM SAÚDE MENTAL

80% dos casos severos de saúde mental estão sem tratamento – OMS.

O Brasil está no topo do ranking de ansiedade e depressão da América Latina. (19mi de pessoas).

→ **necessidade de aumentar a conscientização sobre a importância da saúde mental e vencer o estigma em relação à busca por tratamento profissional.**

Estigma → conjunto de percepções e atitudes negativas, crenças e preconceitos sobre determinada condição ou grupo de pessoas.

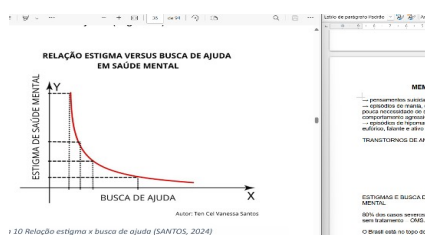
→ medos, estereótipos e mal-entendidos construídos culturalmente.

→ facilitar o acesso aos tratamentos e profissionais especializados é uma medida necessária ao enfrentamento do problema, contudo ainda esbarra no preconceito.

As consequências dos estigmas de saúde mental afetam aqueles que enfrentam os problemas, seus familiares e a sociedade.

Os estigmas levam à marginalização das pessoas que enfrentam problemas mentais e ao desencorajamento da busca de ajuda por parte destas.

→ **a relação entre o estigma e a busca de ajuda é sempre uma relação inversamente proporcional: quanto maior o estigma, menor a busca de ajuda e quanto menor o estigma, maior a busca de ajuda.**



Embora tenha havido alguma melhora na educação sobre saúde mental, o estigma da saúde mental ainda existe hoje.

O processo de redução do estigma e mudança cultural é longo e requer esforços contínuos de todos.

→ campanhas de conscientização tendem a melhorar a compreensão das pessoas sobre a saúde mental e ajudam a construir uma cultura de aceitação, compreensão e apoio.

VITIMIZAÇÃO POLICIAL

“ato em que o policial é vítima de violência letal ou não”.

Pode ser objetiva ou subjetiva.

A vitimização é objetiva quando o policial é alvo de mortes e lesões.

Policiais também foram vítimas de ameaças, assédio moral ou humilhação no ambiente de trabalho e foram discriminados por serem profissionais de segurança pública → vitimização subjetiva.

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o que mais matou policiais militares em 2023 foi o suicídio;

→ ou seja, PMs morreram mais por suicídio do que por confronto na folga ou em serviço. (110 suicídios x 107 mortes em confronto).

O suicídio está entre as três maiores causas de vitimização policial.

Nos parece que um passo importante seria investir na melhora da notificação dos casos de suicídio e na visibilidade dos números e características do fenômeno no intuito de contribuir para a criação de estratégias de prevenção. Sem expor, obviamente, vítimas e familiares, essas informações ajudam a entender qual a proporção do problema.

RECURSOS DE APOIO À SAÚDE MENTAL NA PMPE

A Política de Saúde Mental na PMPE é administrada pelo Núcleo de Saúde Mental (NSM PMPE) criado em 2023.

MEMENTO – SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA

Subordinado à Diretoria de Assistência Social (DAS), o **Núcleo de Saúde Mental atua na promoção, prevenção e assistência em Saúde Mental no âmbito da PMPE**, bem como tem por **objetivo realizar a gestão da política pública de saúde mental da Corporação** e tem as seguintes **atribuições**:

1. Assessorar o CMT-Geral sobre a saúde mental e qualidade de vida dos policiais;
2. Planejar e implementar apoio às unidades;
3. Promover ações de capacitação, educação e conscientização;
4. Produzir e tratar dados e estatísticas de saúde mental;
5. Normatizar a Doutrina de Saúde Mental da PMPE, com a construção de protocolos e orientações voltados à promoção da saúde e prevenção do adoecimento mental;
6. Recepcionar demandas relativas à saúde mental advindas da SDS;
7. Atuar, quando necessário, em parcerias com organizações da sociedade civil, a fim de fortalecer a política pública de saúde mental da Corporação.

O NSM desenvolve ações, programas e projetos em saúde mental, dentre os quais:

- atendimento de psicoterapia presencial e on-line gratuito prioritário para PMs da ativa;
- Programas de suporte entre pares (“Tamojunto”);
- campanhas educativas (ex.: setembro amarelo);
- palestras nas OMEs;
- serviço de apoio psicológico (psicólogo de sobreaviso) para casos de ocorrências traumáticas, mortes e outras crises envolvendo PMs de PE.

O Programa TMJ (SET2024) visa capacitar policiais militares de todo o estado para atuarem na política de suporte de pares.

- 02 focais por OME – praças voluntários e treinados para que possam, em suas unidades, orientar e ouvir colegas de trabalho e, caso estes precisem de ajuda profissional, o policial focal contacta o NSM para o devido encaminhamento psiquiátrico ou psicológico.

→ esta abordagem ajuda a diminuir o estigma da busca pela ajuda em saúde mental e também, a longo e médio prazo, ajuda a proporcionar mudança na cultura policial de invulnerabilidade, encorajando a busca por ajuda, humanizando os processos e prevenindo o adoecimento.

Oferta serviços que visam a prevenção e o cuidado com a saúde mental aos PMs ativos e veteranos que são contribuintes da fundação e seus dependentes.

Gabinete de Psicologia

→ administrado pela FCAS, trabalha em conjunto com o NSM e conta com o serviço de psicologia presencial e também com o apoio de médico psiquiatra.

→ também são oferecidos atendimentos pós-trauma em ocorrência e pós-trauma em suicídio.

→ atua em Recife, Nazaré da Mata, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina.

Núcleo de Apoio ao Dependente Químico (NADEQ)

→ visa acolher, tratar e resgatar PMs que sejam dependentes de substâncias psicoativas que afetam sua saúde mental e convívio social.

→ o PM poderá se apresentar voluntariamente ao local, ser apresentado pelo seu comandante ou encaminhado por psiquiatra, sendo submetido a uma triagem antes de iniciar o tratamento.

Complexo de Qualidade de Vida da PMPE

→ localizado na Vila Militar, oferece aos PMs e seus dependentes assistência com médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, serviços de terapias holísticas e todas as modalidades terapêuticas necessárias à qualidade de vida focada na prevenção.

PROJETO ESCUTA SUSP – MJSP

→ oferece serviço de psicoterapia online e gratuito para profissionais de segurança pública;

→ funciona em Alagoas, DF, MG, PE, RN, MA, e SE.

→ profissionais da PM, PC, PP e do CBM, além de peritos criminais, contam com o atendimento de 42 terapeutas.

Para que os profissionais de segurança pública acessem às consultas, basta acessar o site, preencher o cadastro e anexar uma cópia da funcional.

→ o agendamento é por e-mail e as sessões são on-line e semanais.

MEMENTO – SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA

SUICÍDIO

→ Ainda é um tabu → traz sentimento de culpa e vergonha para certas famílias, pois falta um diálogo maduro entre as pessoas.

“Só existe um pensamento filosófico realmente sério: o suicídio”.
(Albert Camus).

Na **ambivalência**, dois valores, o de morrer ou o de viver.

(VIDA X MORTE)

Querer agora – não querer depois;
Confusão mental – indecisão.

Os suicídios são evitáveis (OMS).

De acordo com a Associação Brasileira de Psicologia (ABP), o **suicídio** é um **ato deliberado executado pelo próprio indivíduo**, cuja **intenção seja a morte de forma consciente e intencional**, mesmo que ambivalente, **usando um meio que ele acredita ser letal**.

Suicídio **NÃO É** egoísmo, covardia, unicausal, explicado unicamente pela doença mental, pecado ou culpa dos enlutados.

O **suicídio está associado a múltiplos fatores**. É multideterminado, multicausal, um **fenômeno complexo e plural**.

É importante destacar que **nem todo paciente mental é suicida**, bem como **nem todo suicida é paciente mental**.

Fases do suicídio:

1. Ideação;
2. Planejamento;
3. Tentativa.

Fatores de risco

- desesperança, desamparo, desespero;
- doença mental;
- impulsividade;
- histórico familiar;
- eventos adversos na infância e adolescência;
- dependência química;
- tentativas anteriores.

Fatores de proteção

- bons laços sociais estabelecidos;
- boa autoestima;
- afiliação religiosa;
- razão para viver;

- acesso a serviços de saúde;
- boa capacidade de adaptação e resolução de problemas.

Faz-se mister mencionar que um profissional que atende a uma **ocorrência de tentativa de suicídio NÃO DEVE partir o princípio que os fatores de risco e de proteção de uma pessoa são estabelecidos previamente**, mas **SEMPRE verificar por meio de escuta e interação comunicativa com a vítima em crise suicida, quais fatores são, de fato, protetivos e de risco naquele momento**.

Doenças mentais mais associadas ao suicídio

- depressão;
- transtorno bipolar;
- abuso de álcool e substâncias;
- psicose esquizofrênica;
- transtornos de personalidade com presença de impulsividade e agressividade.

Gatilhos X Âncoras

Gatilho é o disparador de uma crise suicida, enquanto os fatores especiais que funcionam como **freios para parar ou diminuir as crises são conhecidos como âncoras**.

O que seria uma âncora em Suicidologia?

→ um fator especial que se vincularia a um **forte sentido de vida e valor para uma vítima**.